

Análisis de la situación de la vacunación materna para Virus Sincial Respiratorio

Unidad Centinela -IRAG e IRAG extendida. Hospital Regional de Río Gallegos

Elaboración técnica

Coordinación provincial de redes de laboratorio

Epidemiología MSyA

1. Introducción

La introducción de la vacuna contra VSR en el calendario de la persona gestante representa un hito en la prevención de infecciones respiratorias graves en recién nacidos y lactantes. Sin embargo, su impacto real depende de la cobertura alcanzada, la oportunidad de la vacunación y la dinámica estacional del virus. La evaluación de estas variables requiere de una vigilancia centinela sostenida y nominalizada.

Desde la SE 18/2024, el Hospital Regional Río Gallegos funciona como Unidad Centinela de IRAG e IRAG extendida, permitiendo el seguimiento longitudinal de las internaciones pediátricas, el estudio etiológico por laboratorio y el registro del antecedente vacunal materno. Este abordaje integral es indispensable para interpretar el riesgo residual en lactantes cuyas madres no fueron vacunadas, ya sea por encontrarse fuera del período de campaña, por falta de acceso o por embarazos no controlados.

A continuación, se presenta el análisis de 106 internaciones en menores de 11 meses registradas hasta la SE 32/2026 en el marco de la estrategia UC-IRAG-HRRG, con el objetivo de aportar evidencia local para la toma de decisiones sanitarias y la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación materna.

2. Objetivo general

Describir la situación de la vacunación materna para Virus Sincial Respiratorio (VSR) en los casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) e IRAG extendidas (IRAGE) en menores de 11 meses notificados por la Unidad Centinela del Hospital Regional Río Gallegos entre la semana epidemiológica 18 de 2024 y la semana epidemiológica 32 de 2026, con el propósito de caracterizar la cobertura, oportunidad y brechas de acceso a la vacunación durante la gestación y aportar evidencia para la evaluación del impacto de la estrategia.

3. Ejes de análisis

El presente informe se estructura en torno a los siguientes ejes, con foco en la vacunación materna:

- Situación de la vacunación materna: proporción de lactantes menores de 11 meses internados por IRAG/IRAGE cuyas madres recibieron la vacuna contra VSR durante la gestación.
- Oportunidad de la vacunación: distribución del antecedente vacunal según trimestre y semana de gestación (32 a 36 semanas) y tiempo transcurrido entre vacunación y nacimiento.
- Brechas y motivos de no vacunación: caracterización de los casos sin antecedente vacunal según ocurrencia fuera del período de campaña estacional (enero-agosto), falta de acceso, embarazo no controlado o no registro.
- Relación con la circulación de VSR: correlación temporal entre casos confirmados para VSR y antecedente de vacunación materna por grupo etario priorizado (0 a 2, 3 a 5 y 6 a 11 meses), período de mayor vulnerabilidad para formas graves.

4. Definiciones operativas y criterios de inclusión

La clasificación de los casos se realizó de acuerdo con las definiciones establecidas para la estrategia de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

IRAG Se considera caso de IRAG a todo paciente, de cualquier edad, con infección respiratoria aguda que presenta fiebre referida o constatada mayor o igual a 38 °C, tos, inicio del cuadro en los 10 días previos y requerimiento de internación por criterio clínico.

IRAG extendida Se considera caso de IRAG extendida a pacientes menores de 2 años o personas de 60 años o más que presentan infección respiratoria definida por tos o dificultad respiratoria, inicio del cuadro en los 10 días previos y requerimiento de internación por criterio clínico.

En lactantes menores de 6 meses, también se consideran criterios clínicos relevantes la presencia de apnea o sepsis, entendida como fiebre o hipotermia, shock y cuadro grave sin causa aparente.

Estas definiciones permiten diferenciar los casos captados por la definición clásica de IRAG de aquellos incorporados mediante la estrategia ampliada de IRAG extendida, lo cual resulta fundamental para interpretar adecuadamente la magnitud, severidad e impacto de los eventos analizados.

Para mayor detalle sobre las definiciones operativas, criterios de inclusión, circuito de notificación e indicadores de la estrategia UC-IRAG, consultar la guía operativa nacional vigente: [Guía Operativa UC-IRAG – Ministerio de Salud de la Nación](#)

Definición operativa para el análisis de vacunación materna VSR

Para el presente informe se consideró:

Caso con antecedente de vacunación materna: lactante menor de 11 meses internado por IRAG o IRAG extendida cuya madre recibió vacuna contra VSR entre las 32 y 36 semanas de gestación, con intervalo mayor o igual a 14 días previos al nacimiento.

Caso sin antecedente de vacunación materna: lactante menor de 11 meses sin registro de vacunación materna, o vacunada fuera del intervalo recomendado (menor de 32 o mayor de 36 semanas), o con intervalo menor de 14 días entre vacunación y parto.

Sin dato / no consta: casos donde no se pudo relevar el antecedente en historia clínica, carnet o sistema NOMIVAC.

Período de campaña: para Argentina 2024-2026, la campaña estacional de vacunación VSR en personas gestantes se establece entre enero y agosto inclusive.

El análisis de la situación vacunal se presenta estratificado por grupo etario del lactante de 0 a 2 meses, de 3 a 5 meses y de 6 a 11 meses.

5. Nota metodológica

El presente informe integra información proveniente de la notificación nominal de casos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0.

El período evaluado comprende desde la semana epidemiológica 18 de 2024 hasta la semana epidemiológica 32 de 2026. El procesamiento de los datos se realizó mediante el software R, incluyendo procedimientos de limpieza, depuración, clasificación y análisis descriptivo del antecedente de vacunación materna para VSR.

Los resultados deben interpretarse como información de vigilancia centinela hospitalaria del Hospital Regional Río Gallegos, útil para monitorear tendencias, severidad, circulación de VSR y brechas de vacunación materna, pero no como tasas poblacionales provinciales.

6. Situación epidemiológica

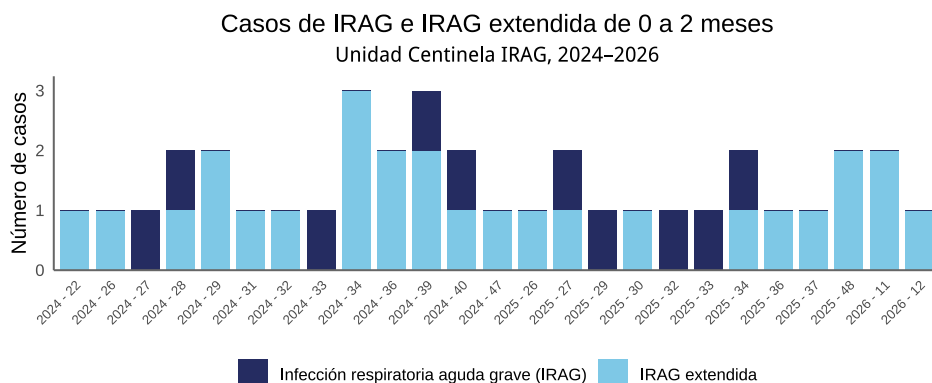
Entre la semana epidemiológica 18 de 2024 y la semana epidemiológica 32 de 2026, se registraron un total de 106 internaciones por IRAG e IRAG extendida en menores de 11 meses notificadas en el marco de la estrategia UC-UCIRAG-HRRG. Este universo constituye la base para el análisis de la situación materna para VSR.

6.1 Distribución temporal según grupo etario

A continuación, se presenta la distribución temporal de los casos notificados en menores de 11 meses. Para mantener coherencia con los criterios operativos de la vigilancia centinela y facilitar la interpretación epidemiológica, el análisis se organiza en tres grupos poblacionales: de 0 a 2 meses, de 3 a 5 meses y de 6 a 11 meses.

6.1.1 De 0 a 2 meses

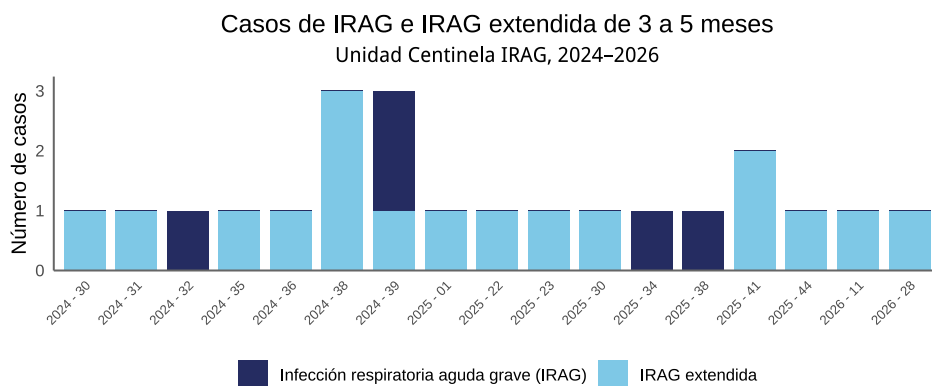
Gráfico 1. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 0 a 2 meses . Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.



Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0

6.1.2 De 3 a 5 meses

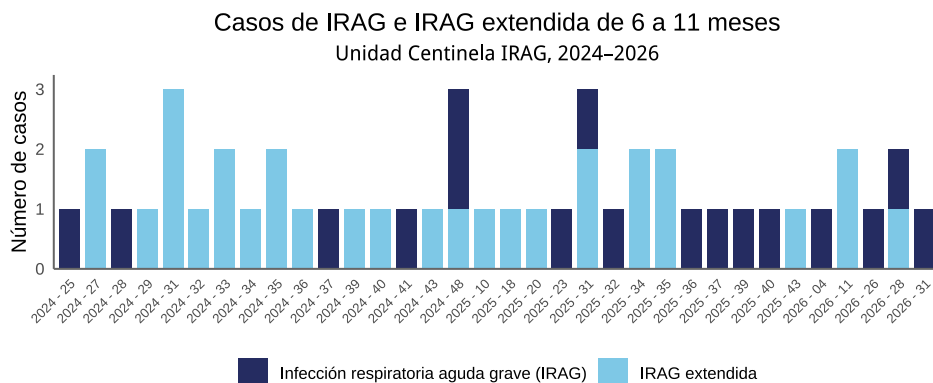
Gráfico 2. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 3 a 5 meses. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0

6.1.3 De 6 a 11 meses

Gráfico 3. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 6 a 11 meses. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

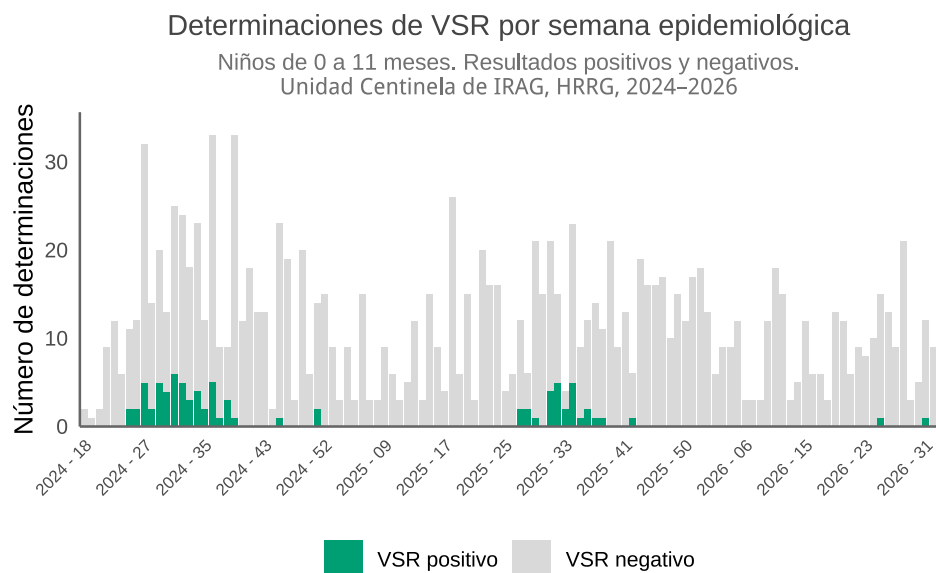


Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0

6.2. Determinaciones para Virus Sincicial Respiratorio en menores de 11 meses

En esta sección se presenta la distribución temporal de las determinaciones realizadas para Virus Sincicial Respiratorio en vigilancia, así como las determinaciones con resultado negativo.

Gráfico 4. Determinaciones para Virus Sincicial Respiratorio Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.



Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SNVS 2.0 y registros del laboratorio HRRG.

6.3 Antecedente de vacunación materna contra el VSR

En pacientes menores de 11 meses internados por IRAG e IRAG extendida, el antecedente de vacunación materna para VSR constituye una variable trazadora para evaluar la implementación de la estrategia.

Durante el período SE 18/2024 a SE 32/2026 se observó una tendencia creciente en la proporción con antecedente vacunal: 13,2% en 2024, 33,3% en 2025 y 40,0% en 2026.

Factores a considerar: periodo estacional enero-agosto, posible subregistro en ámbito privado y embarazos no controlados.

Tabla 1. Antecedente de vacunación materna contra VSR por año

Niños de 0 a 11 meses internados por IRAG/IRAG extendida. HRRG, 2024–2026

Antecedente registrado	2024	2025	2026
Con antecedente de vacunación materna	7 (13,2 %)	12 (33,3 %)	4 (40,0 %)
Sin antecedente de vacunación materna	46 (86,8 %)	24 (66,7 %)	6 (60,0 %)
Sin información	2	3	2
Total de niños internados	55	39	12

Nota: los porcentajes se calcularon entre los casos con información conocida. Los datos de 2026 corresponden al período disponible.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0, NOMIVAC y registros de laboratorio HRRG.

Tabla 2. Semana gestacional de vacunación materna por año

Niños de 0 a 11 meses con antecedente de vacunación materna. HRRG, 2024–2026

Semana gestacional registrada	2024	2025	2026
32 semanas	2	3	0
34 semanas	0	1	0
35 semanas	2	1	0
36 semanas	3	5	1
Otra semana gestacional	0	0	1
Semana gestacional desconocida	0	2	2
Total con antecedente de vacunación materna	7	12	4

Nota: se incluyen únicamente los registros con antecedente de vacunación materna.